

腹壁侵袭性纤维瘤病 21 例临床分析

孟令勤,姚 旭,刘 源,王 勇,刘金钢

Clinical study on 21 cases of abdominal wall aggressive fibromatosis

MENG Lingqin, YAO Xu, LIU Yuan, WANG Yong, LIU Jingang

Department of Surgery, The Shengjing Affiliated Hospital, China Medical University, Liaoning Shenyang 110004, China.

【Abstract】 Objective: To study the clinical feature and treatment of abdominal wall aggressive fibromatosis. **Methods:** To retrospective study the data of 21 cases of abdominal wall aggressive fibromatosis, including 18 primary cases and 3 relapse cases. 16 cases underwent wide excision, 5 cases underwent tumor dissection, 13 cases were treated with artificial patch to rebuild the deletion of abdominal wall, 8 cases received radiotherapy after operation. **Results:** The local recurrence rate was 22.2%, including 1 case underwent wide excision and 3 cases underwent tumor dissection without radiotherapy after operation. **Conclusion:** Aggressive fibromatosis showing aggressive growth, with high recurrence rate, should be well mastered by surgeon. Surgical operation is the optimal treatment, radiotherapy can decrease the local recurrence rate after operation.

【Key words】aggressive fibromatosis; relapse; operation; radiotherapy

Modern Oncology 2012,20(06):1228-1231

【摘要】 目的:探讨腹壁侵袭性纤维瘤病的临床特点 and 治疗方法。**方法:**回顾研究中国医科大学附属盛京医院 2000-2010 年间外科收治的 21 例腹壁侵袭性纤维瘤病例,包括初发 18 例,复发 3 例。术前 3 例复发患者确诊,9 例疑诊。16 例患者行广泛切除,5 例患者行单纯肿瘤切除或切缘不足 2cm。13 例因肿瘤切除后腹部缺损较大用人工补片行腹壁重建。8 例患者术后行放射治疗。**结果:**术后获随访 18 例,复发 4 例,复发率为 22.2%,其中切缘大于 2cm 的 14 例患者中复发 1 例,切缘不足 2cm 且未行放疗的 3 例全部复发。7 例加用放疗者均未复发。补片修补患者无复发及切口疝发生。**结论:**侵袭性纤维瘤呈侵袭性生长,复发率高,应提高对本病的认识。切缘阴性的手术是首选的治疗方法,放疗能降低术后复发率。

【关键词】侵袭性纤维瘤病;复发;手术;放疗

【中图分类号】R730.262

【文献标识码】A

DOI: 10.3969/j.issn.1672-4992.2012.06.43

【文章编号】1672-4992-(2012)06-1228-04

侵袭性纤维瘤病(aggressive fibromatosis)又称韧带样纤维瘤或硬纤维瘤,是一种来源于纤维组织的罕见肿瘤,其发病率占软组织肿瘤的 0.03%,因其显示正常的有丝分裂、不转移的特点,一直被认为是良性病变。但该病具有局部侵袭性,无包膜,即便广泛切除也容易局部复发,约 8% 患者可迅速生长致患者死亡,而 20%-30% 的患者可能出现疾病稳定或自行缓解的特点,有别于其他良性肿瘤^[1],其临床特点及其治疗对策均有其特殊性,值得外科医生重视。我们总结了 2000 至 2010 年间收治的 21 例

腹壁侵袭性纤维瘤病病例,将诊治经验报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组 21 例患者中男性 2 例,女性 19 例;年龄在 19-46 岁之间,平均 31 岁;病史为 2 个月至 5 年;女性病例 17 例有生育史,4 例有腹部手术史,1 例结肠镜检查发现结肠多发腺瘤样息肉;21 例中 18 例为初发病例,3 例为复发病例,其中 2 例为第 2 次复发,1 例为第 3 次复发;所有病例均为单发。

1.2 临床资料

1.2.1 术前资料 21 例患者均是在无意中发现肿瘤,无明显症状,3 例当肿瘤长大后略有胀感。查体为腹壁内的实性、质硬、边界清楚或不太清、表面光滑的卵圆形或圆形肿块,与深层组织相固定。位于腹直肌 6 例,腹外侧肌 4 例,腹外侧肌及胸壁 1 例,腹股沟区 10 例,肿瘤大小 2-15cm 不等。21 例均经 B 超检查,表现为腹壁肌层的低回声实性肿块,8 例边界较清,13 例边界欠清。11 例行 CT 检查,8 例行 MRI 检查,均提示软组织肿块,未能明确定性。术前 3 例复发患者确诊为腹壁侵袭性纤维瘤病,其余 18 例均诊断为腹壁肿物(1 例为胸腹壁肿物),其中 9 例考虑可能为侵袭性纤维瘤病。

【收稿日期】 2011-08-05

【修回日期】 2011-08-24

【作者单位】 中国医科大学附属盛京医院普外科,辽宁 沈阳 110004

【作者简介】 孟令勤(1973-),男,辽宁沈阳人,主治医师,在读博士,主要从事胆道外科及胆管癌发病机制方面的研究。E-mail: mlqdlg@yahoo.com.cn

【通讯作者】 刘金钢(1960-),男,辽宁沈阳人,教授,主任医师,博士生导师,主要从事胆道外科、减肥外科的临床工作及基础研究。E-mail: liujg@sj-hospital.org

1.2.2 手术治疗 采用全麻或连硬外麻醉以获得良好肌松。16例患者因术前诊断或疑诊侵袭性纤维瘤病或术中见浸润性生长或冰冻病理考虑侵袭性纤维瘤病而得以广泛切除(切缘距肿瘤边缘大于2-3cm),4例患者因肿瘤具有假包膜而冰冻病理只报良性及1例患者因临近重要血管神经(腹股沟区)而行单纯肿瘤切除或切缘不足2cm。13例因肿瘤切除后腹部缺损较大而用腹膜内或腹膜外人工补片行腹壁重建。

1.2.3 病理特点 肉眼见17例肿块无包膜,3例具假包膜,1例部分假包膜,实质性,质硬,切面灰白色。镜下见肿瘤由丰富的胶原纤维和少量的纤维细胞构成,核分裂相少,肿瘤边缘可见瘤组织侵入周围肌组织内。诊断为腹壁侵袭性纤维瘤病。

1.2.4 放射治疗及其他治疗 3例复发患者、3例肿瘤巨大患者及2例单纯肿瘤切除患者术后行放射治疗,剂量为50-60Gy。所有患者均未行内分泌治疗及化疗。

1.3 典型病例介绍

患者,女,28岁,以“右腹壁肿物5年”为主诉入院。起初发现右腹部肋弓下缘无痛肿物,约鸡蛋黄大小,未予处置,肿物逐渐增大,半年来增大迅速,并略有发胀不适。无生育史及明显外伤史。查体:右侧胸腹壁可见一隆起肿物,触诊约18cm×14cm大小,左侧界至脐左侧两指,右侧至腋中线,下极至右髂前上棘,上极至锁中线6肋间,边界尚清,质硬,无压痛,活动度差(图1A)。辅助检查:彩超见腹壁及局部肋骨走行层次处实质性团块回声反射,其内回声不均匀,可见丰富彩色血流。肋骨平扫3D-CT示双侧肋骨骨质未见确切异常,右侧第8、9肋间隙变窄。上腹增强CT示脐上偏右腹壁软组织内见一不规则肿块影,大小约12cm×10cm,密度不均,可见高密度分隔样结构,界限清晰,包膜完整。局部肋骨可见骨质破坏,肿块向内推挤肝脏(图2A、B)。肺CT及骨ECT未见远处转移。穿刺活检:倾向间叶源性肿瘤,纤维源性可能大,考虑为良-交界性。术前诊断:右胸腹壁肿物,侵袭性纤维瘤病可能大,不排除纤维肉瘤。全麻下手术,见肿瘤位于腹内斜肌内,前下方有包膜,内侧侵入腹直肌达中线,外侧达腋前线,上方包绕第8、9、10肋前段及肋弓软骨,内面侵袭腹膜及膈肌和胸膜。将肿瘤与受侵肌肉、腹膜、膈肌胸膜、8-10肋骨、肋弓及周围2cm正常组织一同切除,腹腔内无侵袭,以腹膜内防粘连补片修补腹壁缺损。病理肉眼见右胸腹壁肿物15cm×10cm×10cm大小,部分有包膜,周围带有正常肌组织,切面黄白,质硬略韧,内见肋骨及肋软骨,肿物与骨组织关系不清(图3A)。镜下见瘤细胞梭形,编织状、束状排列,侵袭性生长,侵及横纹肌及软骨(图3B)。结果为侵袭性纤维瘤病。术后胸腹壁形态恢复正常,无血清肿及切口疝(图1B)。复查CT示右第8、9、10肋骨缺如,皮下脂肪水肿,肌间隙少许积气(图2C、D)。术后入肿瘤科行放射治疗。

1.4 随访

采用电话或写信方式进行随访。21例患者中随访到18例,3例失访。

2 结果

本组病例无死亡。所有病例由病理学证实诊断。切口均I期愈合,13例用补片修复腹壁的患者中5例出现多少不等的皮下积液,经穿刺抽吸痊愈。随访患者18例,随访时间

为10个月至9年,平均随访时间4年3个月。术后复发4例,复发率为22.2%,其中切缘大于2cm的14例患者中复发1例,切缘不足2cm的4例患者中未行放疗3例全部复发。8例加用放疗患者随访到7例,均未复发,未观察到明显的补片放疗相关性改变。8例未用补片患者中有1例发生切口疝,10例补片修补患者无复发及切口疝发生。

3 讨论

侵袭性纤维瘤病是一种罕见的软组织肿瘤,多为单发,偶有多发。多发生于躯干及四肢,少数发生于内脏,尚有个别发生于骨组织^[2]。病因尚不清楚,约25%的患者局部病灶有创伤史,Goy等^[3]报道的61例患者中有19例发生在曾经手术部位。由于侵袭性纤维瘤病容易发生在产后妇女,在年轻女性患者中,侵袭性纤维瘤病则频繁发生在妊娠期间,说明雌激素在侵袭性纤维瘤病发生的多因素过程中可能扮演重要作用。本组病人4例有腹部手术史,大部分为育龄女性,也说明同样问题。另外,认为本病与遗传因素关系密切,与家族性结肠腺瘤性息肉病具有相关性,在家族性腺瘤性息肉病中其发生率可高达3.5%-32%,而Gardner综合征患者同时发生该病概率高达29%,本组患者只有1例行结肠镜检查发现结肠多发腺瘤性息肉,其他患者均未行结肠镜检查,这与在此方面认识不足有关。

腹壁侵袭性纤维瘤病临床表现为无痛、质硬、边缘不太清楚、与腹壁深层相固定的肿块,故临床中对于已婚或生育期女性发现上述表现的肿块,就应考虑本病诊断,这对有意识的判断手术范围有很大帮助。本组中4例患者因医生对本病不认识,且冰冻病理回报过于简单(良性),而没能行足够范围的手术,导致其中3例没有行后续放疗的患者全部复发。因此,提高对本病的认识极其重要。B超、CT及MRI可明确肿瘤的部位、大小以及范围,以增强CT和MRI为优,但不能区分侵袭性纤维瘤病与其他软组织的肿瘤,且对评估术前肿瘤的边界价值较小。虽然MRI比CT更能够准确地判断肿瘤性质、边界及与血管神经的关系^[4],但确诊仍须靠病理学检查并确定肿瘤浸润范围。

侵袭性纤维瘤病的治疗仍存在争议。治疗的难点在于其具有浸润性生长的特点,容易累及重要组织,使手术彻底切除困难,故复发率极高。Dalen等^[5]对30例侵袭性纤维瘤病患者20年以上的随访研究发现大多数患者仅有轻微症状和功能障碍,而且其症状严重程度与手术次数有关,并建议对无症状或仅有轻微症状的患者进行随访,如肿瘤稳定则不必进行治疗。但目前的认识逐渐趋于一致,即外科治疗是侵袭性纤维瘤病的首选治疗。原则上行切缘至少距肿瘤2-3cm以上的广泛切除,切下标本后应肉眼观察切缘是否为正常组织,如发现白色质硬组织,说明切缘未净,应扩大切除范围,如无法确定,应作冰冻病理检查。Micke等^[6]对切缘状况与肿瘤复发关系作了统计:手术切缘是阴性(R0),仍有较高的局部复发率12%-27%,切缘镜下阳性(R1)患者复发率为42%-68%,切缘肉眼阳性(R2)患者局部复发率为100%,总的来说外科切除后的局部复发率约为40%。虽然可用术中冰冻切片来确定切缘,但是由于取材的局限性,切缘阴性的复发率仍有27%^[7]。故仍以肉眼判定超过肿瘤边缘2cm为标准,本组切缘超过2cm的14例患者中仅复发1例,切缘不足2cm的4例患者中未行放疗3例全部复发,与上述结论相符。



图1 术前术后腹壁形态比较

注: A: 术前; B: 术后

Fig. 1 The appearance of abdominal wall before and after operation

A: Before operation; B: After operation

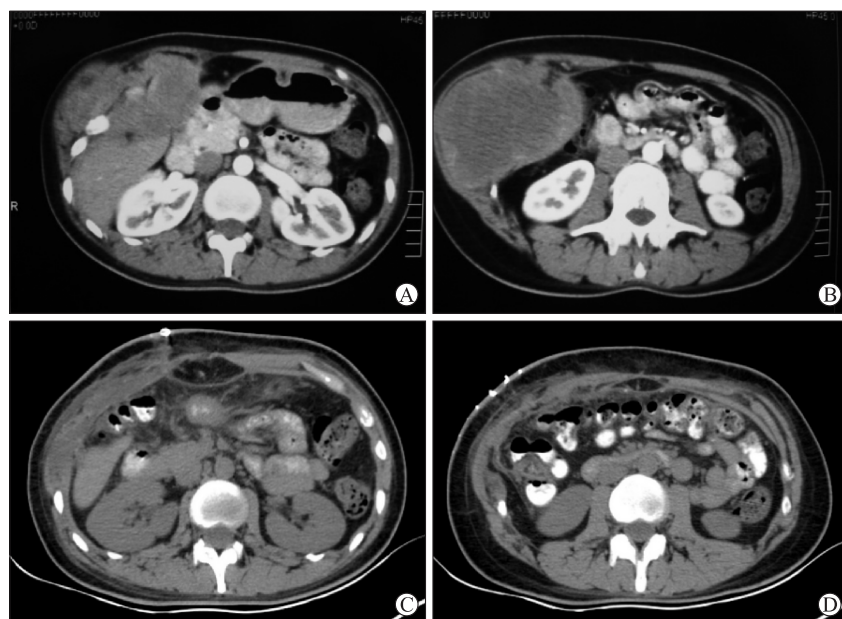


图2 术前、术后 CT 所见

注: A、B 术前; C、D 术后

Fig. 2 CT findings before and after operation

A, B: Before operation; C, D: After operation

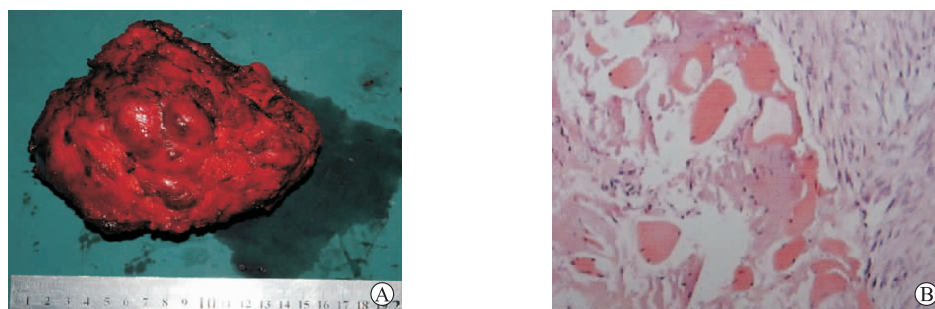


图3 术后病理所见

注: A: 大体所见; B: 镜下所见 (HE × 100)

Fig. 3 The pathology after operation

A: By unaided eye; B: By microscope (HE × 100)

由于本病不发生远处转移,患者多能长期生存,因此,位于四肢者不能为追求“无瘤”的切缘而不惜牺牲重要功能甚至截肢;而位于腹壁者,以前也常因为广泛切除后残留的腹壁缺损难以修复而不能得以根治。但近年来,由于疝外科的快速发展和人工补片的普及,使得大块腹壁缺损不再成为手术的障碍。本组 21 例患者中有 13 例应用补片修补腹壁缺

损,效果良好,使得这些患者得以切除足够的范围而避免复发。这可以解释本组病例的复发率低于以前文献报道的复发率。

放射治疗在侵袭性纤维瘤病治疗中的作用得到了肯定。术后放疗能显著降低局部复发率,对手术切缘阳性患者术后辅以放疗取得了与手术切缘阴性者相似的局控率^[6]。复发

的患者,再次手术切缘虽为阴性仍具有 52% 的复发率^[8],故对于复发病例再手术后主张加用放疗。而单独放射治疗则是不能手术治疗病人的一种有效治疗手段^[9]。本组 3 例复发患者、3 例肿瘤巨大患者及 1 例单纯肿瘤切除患者术后行放射治疗,均未复发。但尽管如此,放疗还是经常被外科医生所忽略。

至于其他治疗方法,雌激素受体阳性患者可能用抗雌激素治疗有效;化疗对不宜手术和放疗的病例可能有一定效果^[10];另外,对 c-Kit 阳性的患者,运用依马替尼治疗可能是较好的选择^[11]。然而这些方法因病例数少还需要进一步观察。

综上所述,提高对侵袭性纤维瘤病的认识至关重要,尽量保证重要器官功能的广泛切除手术是首选治疗方法,放疗能降低术后复发率。

【参考文献】

- [1] Wang CP, Chang YL, Ko JY, et al. Desmoid tumor of the head and neck [J]. Head Neck, 2006, 28(11): 1008-1013.
- [2] 史会明,许建波,杨祚璋. 左髂骨巨大侵袭性纤维瘤 1 例报道 [J]. 现代肿瘤医学, 2009, 17(1): 117-118.
- [3] Goy BW, Lee SP, Eilber F, et al. The role of adjuvant radiotherapy in the treatment of resectable desmoid tumors [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1997, 39(3): 659-665.
- [4] 张禹,朱友志,康健,等. DWI 结合常规 MRI 在侵袭性纤维瘤病诊断中的应用 [J]. 放射学实践, 2010, 25(4): 429.
- [5] Dalen BPM, Bergh PM, Gunterberg BU. Desmoid tumors: a clinical review of 30 patients with more than 20 years' follow-up [J]. Acta Orthop Scand, 2003, 74: 455-459.
- [6] Micke O, Seegenschmiedt MH. Radiation therapy for aggressive fibromatosis (desmoid tumors): results of a national patterns of care study [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2005, 61(3): 882-891.
- [7] Leithner A, Gapp M, Leithner K. Margins in extra-abdominal desmoid tumors: a comparative analysis [J]. J Surg Oncol, 2004, 86(3): 152-156.
- [8] Ballo MT, Zagars GK, Pollack A. Radiation therapy in the management of desmoid tumors [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1998, 42(5): 1007-1101.
- [9] Nuytens JJ, Rust PF, Thomas CR Jr, et al. Surgery versus radiation therapy for patients with aggressive fibromatosis or desmoid tumors: a comparative review of 22 articles [J]. Cancer, 2000, 88(7): 1517-1523.
- [10] Skapek SX, Ferguson WS, Granowetter L. Vinblastine and methotrexate for desmoid fibromatosis in children: results of a Pediatric Oncology Group Phase II Trial [J]. J Clin Oncol, 2007, 25(5): 501-506.
- [11] Lev D, Kotilingam D, Wei C, et al. Optimizing treatment of desmoid tumors [J]. J Clin Oncol, 2007, 25(5): 1785-1791.

(编校:徐萌)

62 例阴茎鳞状细胞癌治疗的临床分析

宋彦,宋永胜,吴斌

Diagnosis and treatment of sixty-two penile squamous cell carcinoma

SONG Yan, SONG Yongsheng, WU Bin

Department of Urology, Shengjing Hospital, China Medical University, Liaoning Shenyang 110004, China.

【Abstract】 Objective: To study the rational and effective treatments for penile squamous cell carcinoma (PSCC).

Methods: Retrospectively analyzed the clinical data of 62 cases of pathologically confirmed PSCC, focusing on the treatment methods. **Results:** Fifty four of the 62 patients were treated by surgery, of whom 45 underwent limited resection of the tumor or partial amputation of the penis, and the other 9 received total penis amputation plus perineal urethrostomy. 31 underwent lymph nodes biopsy, 9 were positive and moved to clearance of lymph nodes. 5 of the patients whom underwent limited resection of the tumor or partial amputation of the penis experienced local recurrence and thus underwent total penis amputation plus perineal urethrostomy and clearance of lymph nodes. Based on Jackson Staging, 29 of the 54 cases were in stage I, 18 stage II, 11 stage III, and 4 stage V. 43 cases were high differentiated squamous cell carcinoma, 7 cases were middle differentiated squamous cell carcinoma and 4 cases were poor differentiated squamous cell carcinoma. The 2-7 years follow-up rate was 70.9%. The 3 and 5-year survival rates were 90.9%, 75%, respectively. The 5-year survival rate for non-surgery treatment was only 50%. **Conclusion:**

【收稿日期】 2011-10-17

【修回日期】 2011-11-09

【作者单位】 中国医科大学附属盛京医院泌尿外科, 辽宁 沈阳 110004

【作者简介】 宋彦(1980-),男,四川成都人,医师,主要从事泌尿系肿瘤相关研究工作。

【通讯作者】 宋永胜(1963-),男,辽宁沈阳人,主任医师,主要从事泌尿系肿瘤相关研究工作。E-mail: alexander-song@163.com